

徐华芳的个案护理

病区	65 病区	床号	102	姓名	徐华芳
性别	女	年龄	93	住院号	612290
诊断	高血压病 3 级（极高危）；帕金森病；认知障碍；阵发性心房颤动；室性期前收缩；房性期前收缩（房性早搏）；脑梗死后遗症；营养不良；低蛋白血症；胸腔积液；全身炎症反应综合征；急性肾功能不全				
一、主要病情					
1. 现病史	患者徐华芳，女，93 岁，因“高血压病 50 余年，控制欠佳 1 周”于 2026/08/05 入院。既往血压最高约 200/100 mmHg，长期根据血压波动调整降压方案。 住院后患者痰液增多，胸部影像提示肺部渗出较前增多；痰培养及药敏后先后予抗感染、抗真菌及化痰等治疗。2026/08/17 出现少尿及代谢性酸中毒，随后肌酐升高。2026/08/22 突发低血压（最低约 83/45 mmHg），短期予去甲肾上腺素维持血压后转监护室进一步治疗。 监护室期间予心电监护、气管切开接面罩吸氧及 BiPAP 辅助通气交替、抗感染/抗凝、营养支持及维持水电解质平衡等治疗，炎症指标好转后于 2026/08/27 转入 65 病区。现仍病危、一级护理，呼之可睁眼但无指令性动作，继续气道管理、营养支持及严密监测。				
2. 既往史	疾病史： 1. 高血压病史 50 余年，血压波动明显，长期口服降压药。 2. 帕金森病、认知障碍、脑梗死后遗症。 3. 阵发性心房颤动、室性期前收缩、房性期前收缩。 4. 骨质疏松、骨关节病；右侧陈旧性股骨颈及股骨粗隆间骨折，2022 年曾行手术治疗。 5. 左侧肝占位性病变、肿瘤标记物升高、椎管内肿物。 6. 胃术后及胆囊切除术后状态，长期气管造口。 7. 焦虑状态；药物过敏史：青霉素。				
3. 特殊检查	1. 2026/08/17 血气分析：pH 7.28，PaCO₂ 28 mmHg，PaO₂ 226 mmHg，实际碳酸氢盐 13.1 mmol/L，标准碳酸氢盐 15 mmol/L，剩余碱-12.1 mmol/L，提示代谢性酸中毒。 2. 住院期间床旁胸片提示肺部渗出较前增多；痰培养提示白假丝酵母菌阳性。 3. 2026/08/21 床旁超声提示右侧枕部皮下水肿。 4. 监护室气道检查提示声门上组织水肿。				

	5. 2026/08/28 心肌标志物：BNP 6091 pg/mL，心肌肌钙蛋白 T 0.071 ng/mL 升高。
4. 异常化验	2026/08/27-08/28 主要异常指标： 1. 血红蛋白 96 g/L、红细胞计数 $3.40-3.62 \times 10^{12}$ /L、红细胞压积 29.3%-31.5%，提示贫血；血小板 119×10^9 /L 降低。 2. 淋巴细胞计数 $0.47-0.51 \times 10^9$ /L、淋巴细胞百分比 11.2%-11.5%，均降低。 3. 肌酐 187 μmol/L、尿素 13.7 mmol/L 升高，eGFR 20 mL/min/1.73m² 降低；二氧化碳 20 mmol/L、血钙 1.99 mmol/L 降低。 4. CRP 5.3 mg/L 升高。 5. D-二聚体由 0.95 升至 2.11 mg/L，FDP 6.55 μg/mL 升高；APTT、PT 轻度延长。 6. BNP 6091 pg/mL、心肌肌钙蛋白 T 0.071 ng/mL 升高。
二、目前主要治疗措施	
治疗原则	1. 病危、一级护理，持续心电监护，动态监测生命体征及血压变化。 2. 气管切开接面罩吸氧与 BiPAP 辅助通气交替；按需湿化、雾化、吸痰，维持气道通畅。 3. 记录 24 小时出入量，动态监测肾功能、电解质及酸碱平衡，遵医嘱利尿、补钙、补钠并调整液体治疗。 4. 遵医嘱使用贝米肝素钠抗凝，结合血小板、凝血指标及痰中带血情况动态调整。 5. 鼻肠管给予肠内营养（百普素 0.5 袋+温水 500 mL，qd）并配合静脉营养、白蛋白等营养支持；每日鼻饲水约 400 mL。 6. 遵医嘱给予降压、抗心律失常、抗帕金森、化痰、抑酸、雾化吸入及对症支持治疗。
三、目前主要观察要点	
1. 生命体征	2026/08/28 10:00：T 36.5℃，P 60 次/分，R 12 次/分，BP 137/55 mmHg，SpO₂ 100%。 2026/08/28 12:00：P 63 次/分，R 12 次/分，BP 133/63 mmHg，SpO₂ 100%。 心律可不齐；静息 NRS 疼痛评分 0 分。
2. 伤口及导管	伤口/皮肤：全身水肿；骶尾部约 5×5 cm 陈旧性红白色瘢痕，双侧髋部各约 3×3 cm 红白色瘢痕并有散在皮损，骨突处及骶尾部予泡沫敷料保护；后颈部肿胀。 目前置管： 1. 气管切开套管：接面罩吸氧，气囊充气，按需湿化吸痰；可吸出黄白色或白

	色黏痰，量较多。 2. 左侧 CVC：固定妥，无红肿、无外渗。 3. 鼻肠管：固定妥，用于肠内营养及鼻饲给药。 4. 留置导尿管：固定妥，尿液黄色，持续观察尿量及性状。
3. 体位与活动	卧位：卧床，取抬高床头及防误吸体位；四肢水肿，适当抬高。 活动：目前无自主活动能力，协助每 2 小时翻身，进行被动关节活动及肢体功能维护。
4. 自理能力	ADL 生活活动能力量表 5 分，为重度依赖；生活照护需由护理人员及照护者完成。
5. 跌倒风险	跌倒风险临床判定 18 分，为高风险；卧床期间落实床栏、警示标识及转运陪护。
6. 压力性损伤风险	Braden 评分 12 分，为压力性损伤高度危险；Cubbin-Jackson 评分 30 分，为低风险。结合现有水肿及皮损，按高风险落实气垫床、翻身减压和皮肤观察。
7. DVT 风险	Padua 静脉血栓风险评分 9 分，为高危；卧床、高龄及活动受限，需落实机械/药物预防并观察出血及下肢血栓征象。
8. 营养风险	NRS-2002 评分 6 分，有营养风险；存在营养不良、低蛋白血症及吞咽障碍，给予鼻肠管肠内营养并结合静脉营养支持。
9. 医院获得性肺炎风险	医院获得性肺炎风险评分 19 分，为超高危险；气管切开、痰液多且咳痰能力差，需加强气道管理及感染监测。
10. 手术并发症	目前无新发手术并发症。重点观察气管造口、CVC、鼻肠管及导尿管相关并发症，并防范误吸、肺部感染、出血、血栓及压伤。
四、现存及潜在的护理诊断及措施	
(一) 现存问题	1. 气体交换障碍 —— 与气管切开、痰液潴留及肺部感染有关 护理措施： 1. 持续观察呼吸频率、节律、SpO₂及缺氧表现，异常及时报告。 2. 取抬高床头/半卧位，按医嘱面罩吸氧与 BiPAP 辅助通气交替。 3. 保持气道湿化，按需吸痰、叩背，记录痰液颜色、量和性状。 4. 做好气管切开护理，监测气囊压力，严格无菌操作并预防呼吸机相关感染。
	2. 营养失调：低于机体需要量 —— 与吞咽障碍、长期卧床及低蛋白血症有关 护理措施： 1. 依医嘱经鼻肠管给予肠内营养，输注时抬高床头 30° -45°，输注后保持体位 30 分钟以上。 2. 观察腹胀、腹泻、反流及误吸征象，记录摄入量和排便情况。

	3. 定期监测体重、血红蛋白、白蛋白、电解质及肾功能，按需联系营养师。 4. 做好口腔护理和鼻肠管维护，确保管路固定与通畅。
(二) 潜在问题	1. 误吸风险 —— 与意识障碍、吞咽障碍、气管切开及鼻肠管喂养有关 护理措施： 1. 持续采取防误吸体位，床头抬高 30° -45°，翻身及操作时保护气道。 2. 喂养前确认鼻肠管位置与通畅，严格控制速度和单次量。 3. 观察呛咳、呼吸困难、SpO₂下降及痰液变化，必要时暂停喂养并通知医生。 4. 床旁备吸引装置，按需行声门下分泌物吸引及气管切开吸痰。 2. 静脉血栓形成风险及皮肤完整性受损风险 —— 与高龄、长期卧床、水肿、营养不良和活动受限有关 护理措施： 1. 每 2 小时翻身，使用气垫床和减压敷料，保持皮肤清洁干燥，重点观察骶尾部、髌部及骨突处。 2. 抬高水肿肢体，进行被动踝泵及关节活动，观察下肢周径、皮温、颜色、疼痛和肿胀。 3. 遵医嘱落实抗凝治疗，监测血小板、凝血指标、皮肤黏膜及痰液有无出血。 4. 严格维护 CVC 和导尿管，落实导管相关感染预防。
五、健康教育	
(一) 饮食指导	1. 目前以鼻肠管肠内营养为主，严格执行医嘱配方、速度及冲管水量，不自行经口喂食。 2. 营养输注时及输注后保持床头抬高，观察反流、呛咳、腹胀、腹泻等情况。 3. 每日记录摄入量、排便及体重变化；出现喂养不耐受及时告知医护人员。
(二) 伤口/导管	皮肤方面： 1. 每 2 小时协助翻身，避免拖、拉、推；保持骶尾部、髌部及会阴部清洁干燥。 2. 观察瘀痕、破损及水肿部位，敷料污染、松脱或渗液时及时更换并报告。 导管方面： 1. 向家属说明气管切开、CVC、鼻肠管及导尿管的用途，勿自行牵拉或拔除。 2. 保持各管路固定、通畅，出现红肿、渗液、堵塞、脱出或尿量异常时及时通知医护人员。
(三) 药物指导	1. 青霉素过敏，任何诊疗环节均应主动告知医护人员。 2. 抗凝药：观察皮肤黏膜、痰液、尿液及大便有无出血，出现异常立即报告。 3. 降压及抗心律失常药：按时服用，密切监测血压、心率，不自行停药或调量。 4. 抗帕金森及其他药物须按医嘱经鼻肠管给药，注意嗜睡、低血压等不良反应。
(四) 活动指导	卧床协助翻身及肢体被动运动；转运时保护气切和导管，异常立即停止并报告。

